Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Estadual da Saúde Pública

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacentvesp@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5207203-08.2025.8.21.0001/RS

AUTOR: JORGE ALFREDO BORBA SILVEIRA

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

JORGE ALFREDO BORBA SILVEIRA ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do IPÊ-SAÚDE. Alegou possuir diagnóstico de **neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas (CID10-C22.0)**, **EC IV**, e que, em razão disso, necessita fazer uso dos medicamentos **IPILIMUMABE 70mg e NIVOLUMABE 240mg**, porém o pedido foi negado administrativamente. Requereu, em tutela de urgência, a determinação de fornecimento dos fármacos pelo réu (evento 1, INIC1).

Determinada a complementação dos documentos (evento 5, DESPADEC1), a parte autora anexou-os no Evento 9.

Requisitada nota técnica (evento 5, DESPADEC1; evento 11, OUT1), sobreveio com conclusão favorável (evento 12, NOTATEC1).

Indeferida a gratuidade (evento 14, DESPADEC1).

Deferida a tutela de urgência (evento 25, DESPADEC1).

Devidamente citado, o réu apresentou contestação (evento 33, PET1), pugnando, em síntese, pela improcedência.

Houve réplica(evento 53, RÉPLICA1).

O Ministério Público emitiu parecer de mérito, opinando pela procedência da ação (evento 67, PROMOÇÃO1).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, em conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria discutida é eminentemente de direito, e os fatos relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente instruídos e comprovados pela robusta prova documental já acostada aos autos.

Conforme o laudo médico anexado aos autos (evento 9, OUT5), a parte autora apresenta um diagnóstico de patologia registrada sob o CID10-C22.0, necessitando dos fármacos ipilimumabe e nivolumabe:

PACIENTE

JORGE ALFREDO BORBA SILVEIRA CPF: 366.739.000-91

Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A PEDIDO QUE O PACIENTE JORGE ALFREDO BORBA SILVEIRA JÁ UTILIZOU SORAFENIBE (10/2022 - 04/2023) E PEMBROLIZUMABE PARA HEPATOCARCINOMA, EC IV. A ÚLTIMA PROGRESSÃO, EM VIGÊNCIA DE TRATAMENTO, FOI EM 04/2024, NA QUAL FOI SUSPENSO PEMBROLIZUMABE (EM USO DESDE 01/2024) POR AUMENTO DE LESÕES HEPÁTICAS. DESDE ENTÃO, A DOENÇA APRESENTA AUMENTO PAULATINO, BEM COMO AUMENTO DE ALFAFETO PROTEÍNA.
FOI ENCAMINHADA A SOLICITAÇÃO AO CONVÊNIO DO PACIENTE DO ESQUEMA DE IPILIMUMABE E NIVOLUMABE, NO ENTANTO, O PROPRIO SISTEMA DO CONVÊNIO (IPERGS) NÃO PERMITE AO MÉDICO A INCLUSÃO DESSAS DROGAS NA SOLICITAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO VISTO QUE O CONVÊNIO NÃO TEM ESTE ESQUEMA NOS SEUS PROTOCOLOS PADRÃO.
DESTA FORMA, O CONVÊNIO NEGOU O TRATAMENTO AO PACIENTE À SUA MANEIRA.
MAS A RECOMENDAÇÃO DO PROTOCOLO STRIDE, NESTA SITUAÇÃO, SE DÁ APÓS PROGRESSÃO À SORAFENIBE E PEMBROLIZUMABE, VISTO QUE PACIENTE POSSUI VARIZES ESOFÁGICAS DE GRANDE CALIBRE E NUNCA FOI EXPOSTO A TERAPIA COM INIBIDOR DE CTLA4. PACIENTE TAMBÉM APRESENTA CONTROLE DA HEPATOPATIA SUBJACENTE, SENDO CLASSIFICADO COMO CHILD A E SE APRESENTA SEM NENHUM DECRÉSCIMO DE SEU STATUS CLÍNICO POR ORA. EM AVALIAÇÃO GERIÁTRICA, REALIZADA ATRAVÉS DA G8 SCREENING TOOL, APRESENTA PONTUAÇÃO DE 16 (SCORE MÁXIMO POSSÍVEL).

CID C 22.0

Adicionalmente, a Nota Técnica emitida pelo e-NatJus (evento 12, NOTATEC1) corroborou a necessidade do tratamento, apresentando uma conclusão favorável ao uso do fármaco:

Tecnologia: NIVOLUMABE

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: Embora não existam estudos robustos na literatura testando esta terapia de segunda linha contra os medicamentos disponíveis pelo IPESaude, há elementos técnicos, incluindo novos estudos utilizando a associação como tratamento de primeira linha, que indicam que pode haver algum benefício. Entretanto, não há estudos econômicos e, embora o parecer seja favorável do ponto de vista técnico quanto a um possível benefício clínico, o mesmo não pode ser afirmado em relação à custo-efetividade do medicamento.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim

Justificativa: Com risco potencial de vida

O réu, por sua vez, na contestação apresentada, não trouxe elementos técnicos ou médicos que refutassem a indicação da médica assistente ou a eficácia do Pembrolizumabe para a patologia da autora.

É imprescindível salientar que o médico assistente, em sua função primordial de zelar pela saúde e bem-estar do paciente, é quem detém a melhor capacidade para indicar o tratamento mais adequado e com maior eficácia. A autonomia médica, nesse contexto, deve ser respeitada, não podendo ser sobreposta por meras questões administrativas ou protocolares de um plano de saúde, especialmente quando a vida do paciente está em risco.

A Lei Complementar Estadual nº 12.134/04, que regulamenta o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul (IPE-SAÚDE), em seu artigo 2º, estabelece que o plano abrange "os atendimentos médicos, hospitalares, os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, bem como ações de prevenção da doença e à promoção da saúde".

Mesmo com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 15.145/2018, que em seu artigo 4º, § 1º prevê a exclusão de procedimentos não previstos nas tabelas próprias do Instituto, é consolidado o entendimento de que tal exclusão não pode ser interpretada de forma restritiva a ponto de inviabilizar tratamentos essenciais e comprovadamente eficazes para doenças graves.

A negativa de cobertura calcada exclusivamente na ausência de previsão do fármaco nas tabelas do IPE-Saúde ou em seu protocolo oncológico não se sustenta diante da robustez das provas que demonstram a necessidade e a urgência do tratamento, a eficácia do medicamento e a inexistência de alternativa terapêutica equivalente disponibilizada pela rede. A finalidade precípua de um plano de saúde é a proteção à saúde e à vida de seus beneficiários. Limitar o acesso a um tratamento vital, chancelado pela ciência e pela ANVISA, por razões meramente burocráticas, desvirtua o propósito da própria instituição e coloca em risco bens jurídicos fundamentais constitucionalmente protegidos.

Neste sentido, entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

> *APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. IPE-SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RIBOCICLIBE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei Complementar Estadual n. 12.134/2004, atualizada pela Lei n. 15.145/2018, prevê que o Plano IPE-SAÚDE integra atendimentos médicos, hospitalares e os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, bem como ações de prevenção de doença e promoção da saúde.2. A Resolução n. 021/1979, que regulamenta a Assistência Médico-Hospitalar do Instituto, estabelece que o plano cobrirá os atendimentos médicos hospitalares e os atos necessários ao diagnóstico ou tratamento, incluindo a especialidade de oncologia.3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode selecionar o tipo de tratamento dispensado ao segurado.4. O laudo médico comprova que a parte autora é portadora de neoplasia maligna de mama com metástases ósseas, sendo o medicamento postulado imprescindível para aumentar sua sobrevida, sob risco de progressão da doença e morte.5. A negativa de fornecimento do medicamento por não estar incluído no protocolo utilizado pelo Instituto não pode prosperar, pois o tratamento pleiteado está incluído na especialidade de oncologia, com previsão expressa de fornecimento pelo IPE-Saúde. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50006546820248210043, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 06-10-2025)*

Por fim, o Ministério Público, em seu parecer de mérito (evento 67, PROMOÇÃO1), ratificou a obrigação do demandado em fornecer o fármaco postulado pela autora, fundamentando sua opinião na amplitude da cobertura legal do IPE-Saúde e na comprovação da necessidade do medicamento por laudo médico e Nota Técnica favorável, opinando pela procedência da ação.

Diante do exposto, e considerando a gravidade da enfermidade que acomete a parte autora, que inclusive implica em risco de vida, não se mostra razoável limitar as alternativas terapêuticas disponíveis para o seu tratamento a protocolos que não conseguem acompanhar a velocidade dos avanços da medicina. O descumprimento do IPE-SAÚDE em fornecer o tratamento adequado configuraria uma efetiva negativa de cuidado à saúde da autora, expondo-a a risco de dano irreparável.

Ante o exposto, resolvendo o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por **JORGE ALFREDO BORBA SILVEIRA** contra o **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL**, tornando definitivos os efeitos da decisão antecipatória de tutela, para o fim de determinar ao IPE-SAÚDE que forneça os medicamentos ipilimumabe e nivolumabe na forma e posologia prescritas pela médica assistente da autora, enquanto necessários ao seu tratamento.

Quando do cumprimento de sentença, a parte autora deverá apresentar receita atualizada diretamente ao réu, semestralmente, para que seja mantido o tratamento deferido, sob pena de desobrigação do réu em continuar a fornecer a prestação de saúde.

Isento o demandado do pagamento da Taxa Única de Serviços Judiciais, consoante o previsto no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 14.634/14.

Condeno o demandado ao pagamento das despesas processuais não abrangidas pela taxa única (artigos 14 e seguintes da Lei nº 14.634/2014), bem como ao ressarcimento à parte autora das custas processuais adiantadas e ao pagamento de honorários sucumbenciais ao procurador da parte autora, que fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Em conformidade ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, o valor dos honorários deverá ser atualizado monetariamente pela Taxa SELIC a contar da data da sua fixação, com incidência de juros moratórios, segundo o mesmo índice da Taxa SELIC, a contar do trânsito em julgado, conforme artigo 85, §16, do Código de Processo Civil.

Decisão não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Interposto recurso de apelação, cumpram-se as formalidades dos parágrafos 1º e 2º do artigo 1.010 do Código de Processo Civil e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Nos termos do Ofício-Circular nº 77/2019 CGJ, a fase de cumprimento de sentença deve ser requerida em novo processo, distribuído no Sistema Eproc, vinculado ao processo de conhecimento.

Com o trânsito em julgado, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **RENAN ALEXANDRE IORIS, Juiz Substituto**, em 29/01/2026, às 14:25:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10099169171v5** e o código CRC **5e223adb**.